

Plan Centrado en la Persona (PCP) — Enfoque Transdisciplinario

Documento académico de maestría · Caso anonimizado

Los datos identificativos de la estudiante, de su familia y del equipo profesional han sido retirados de este documento. Se conserva únicamente la información pedagógica y metodológica.

Documento académico elaborado para fines de maestría. Integra la Planificación Centrada en la Persona, la Matriz de Comunicación de Rowland, el enfoque de funcionamiento (CIF), la educación inclusiva y la evidencia científica sobre equinoterapia, con aplicación directa al caso de la estudiante.

Introducción

La atención educativa de estudiantes con discapacidad múltiple exige modelos de evaluación y planificación que superen los enfoques clínicos tradicionales y se orienten hacia la participación, la calidad de vida y el respeto por la diversidad humana. En este contexto, la Planificación Centrada en la Persona (PCP) se consolida como un enfoque ético y pedagógico que sitúa a la persona y su entorno en el centro de las decisiones educativas.

El presente documento desarrolla un Plan Centrado en la Persona para la estudiante, con diagnóstico de Parálisis Cerebral Infantil diparética espástica, desde una perspectiva transdisciplinaria. El plan se fundamenta en la evaluación funcional de la comunicación expresiva de la estudiante y este se realizó mediante observación directa, interacción cotidiana, fundamentado con reporte de información familiar, se complementa con literatura científica actual y se articula con instrumentos conocidos como la Matriz de Comunicación, integrando además la equinoterapia como estrategia terapéutica complementaria.

1. Perfil de la Estudiante

La estudiante es una niña en edad preescolar con diagnóstico de Parálisis Cerebral Infantil diparéctica espástica. Presenta alteraciones del tono muscular, control postural y movilidad, con mayor compromiso en los miembros inferiores. No se reportan alteraciones auditivas ni visuales. Requiere apoyos físicos, posturales y comunicativos permanentes para garantizar su participación segura y funcional en el entorno educativo.

I.- Datos Relevantes

Fecha de la evaluación: 13 /12/ 2025

Participación y responsabilidades del equipo intradisciplinar y transdisciplinar

El Plan Centrado en la Persona de la estudiante se desarrolla a partir de un trabajo intradisciplinar y transdisciplinar coordinado, en el que cada profesional aporta desde su campo de especialización, compartiendo objetivos comunes y estrategias integradas, con la participación activa de la familia.

La coordinación del equipo garantiza que las intervenciones no se realicen de forma fragmentada, sino que se articulen en un plan único, coherente y centrado en la persona.

Especialistas que realizan El PCP

- Licenciada en Educación Especial — coordinadora del proceso (autora de este plan)
- Licenciado en Educación Física
- Licenciada en Pedagogía en Idiomas
- Licenciada en Educación Parvularia
- Licenciada en Terapia Física
- Licenciada en Fonoaudiología

Familia

La familia es reconocida como miembro activo del equipo, participando en la toma de decisiones y en la implementación de estrategias en el hogar. Su conocimiento cotidiano de la estudiante es fundamental para asegurar la coherencia y sostenibilidad del Plan Centrado en la Persona.

El equipo acompaña y orienta a la familia, respetando sus tiempos, recursos y prioridades.

Docente de Educación Especial / Coordinadora del proceso

Es el profesional responsable de dirigir el proceso de evaluación, planificación y seguimiento del Plan Centrado en la Persona. Su función principal es garantizar la coherencia entre las evaluaciones funcionales, las decisiones pedagógicas y las actividades implementadas en los distintos contextos.

Además:

- Coordina la comunicación entre los miembros del equipo
- Asegura la participación activa de la familia
- Adapta el currículo y las actividades desde el enfoque DUA
- Supervisa la generalización de aprendizajes en el aula y el hogar

Fonoaudióloga / Especialista en comunicación

Su participación se centra en el desarrollo de la comunicación funcional, tomando como base la Matriz de Comunicación. Evalúa las formas comunicativas de la estudiante y orienta al equipo

y a la familia en la interpretación y respuesta adecuada a sus señales comunicativas.

Contribuye mediante:

- Orientación en el uso de claves táctiles y verbales
- Validación de la conducta como forma de comunicación
- Apoyo en la construcción de rutinas comunicativas funcionales

Terapeuta Física

Interviene en el área motriz y postural, orientando al equipo sobre:

- Posicionamiento adecuado
- Cambios posturales seguros
- Prevención de fatiga y sobreesfuerzo

Su trabajo se articula con las actividades educativas, favoreciendo la participación funcional de la estudiante en las rutinas diarias y la transferencia de habilidades a contextos naturales.

Licenciado/a en Educación Física

Apoya el desarrollo de experiencias de movimiento adaptadas, centradas en la participación y el disfrute, más que en el rendimiento físico. Colabora en actividades que

favorecen:

- La conciencia corporal
- La movilidad asistida
- La interacción a través del movimiento

Docente de Educación Inicial / Parvularia

Aporta conocimientos sobre el desarrollo infantil temprano y las rutinas propias de la edad. Su rol es adaptar las actividades educativas para que sean accesibles, significativas y coherentes con el nivel de desarrollo de la estudiante, favoreciendo la inclusión y la participación en el entorno escolar.

Equipo de Equinoterapia

Integra la equinoterapia como intervención complementaria, orientada a la regulación postural, emocional y sensorial. El equipo comparte con los demás profesionales las observaciones relevantes, permitiendo generalizar los beneficios de la equinoterapia a otros contextos como el aula y el hogar.

Datos Clínicos

Diagnóstico: Parálisis cerebral diparética espástica (aumento de

tono muscular con mayor compromiso neurológico a miembros inferiores en relación con miembros superiores, lo cual afecta su desempeño motor para la ejecución de ciertas actividades de la vida diaria).

Aspectos importantes de salud:

La estudiante presenta Parálisis Cerebral infantil diparética espástica, condición neurológica permanente que se asocia a alteraciones del tono muscular, control postural y equilibrio, con compromiso significativo del área motriz y retraso severo del desarrollo global; requiere apoyos físicos y posturales constantes para la movilidad y la participación en actividades, así como supervisión permanente durante las jornadas educativas para garantizar su seguridad y bienestar; se observa hipertonía generalizada asociada a su cuadro clínico,

torpeza motriz y limitada resistencia postural, lo que puede generar fatiga durante las actividades prolongadas; responde favorablemente a la contención emocional y al acompañamiento de un adulto, siendo recomendable mantener rutinas estructuradas, pausas activas y coordinación continua con la familia y los servicios terapéuticos que la atienden. Otras condiciones de importancia: (medicación u otros) : Toma zinc y multivitaminas.

Potencialidades

La niña presenta un funcionamiento visual básico, con mejor respuesta a estímulos cercanos y frontales, atención visual breve y seguimiento visual incipiente; reconoce a personas significativas y no se evidencian alteraciones sensoriales visuales, observándose limitaciones funcionales asociadas a su condición neurológica, por lo que requiere mediación constante y adaptaciones visuales para su participación educativa.

Fortalezas Identificadas

- Respuesta positiva al acompañamiento emocional y a la presencia de adultos significativos.
- Buena tolerancia al contacto físico respetuoso y a la guía corporal.
- Mayor funcionalidad relativa en miembros superiores.
- Beneficio evidente de rutinas estructuradas y predecibles.
- Respuesta favorable a la equinoterapia, con mejor regulación postural y emocional.
- Uso del tacto como canal principal de acceso e interacción.

Habilidades

Respuesta a sonidos de la voz

La estudiante percibe la voz humana, especialmente cuando se utiliza un tono cercano, suave y constante, a corta distancia. Puede responder mediante:

- Cambio de expresión
- Disminución de la actividad motriz
- Breves vocalizaciones

Motivaciones

Respuesta a sonidos musicales

Ante estímulos musicales como tambor, campana, pandereta, pito, latas, piano y música

grabada, se observan respuestas variables. Algunos sonidos generan:

- Aumento del movimiento corporal
- Vocalizaciones espontáneas
- Cambios en la postura.

Los instrumentos de percusión suave y la música rítmica generan mayor interés que los sonidos agudos o abruptos.

Necesidades Específicas

Modificaciones, uso de aparatos, entrenamiento auditivo, evaluación auditiva formal, concepto objeto-sonido, ritmos a usar, sonidos ambientales a estimular, canciones a incluir, intensidad del sonido a usar o estimular, tipos de juguetes sonoros a usar.

Necesidades Identificadas En El Entorno Familiar Y Amistoso

La estudiante participa de manera pasiva en las rutinas familiares, dependiendo de la mediación del adulto para comprender la situación. Se entera de los acontecimientos familiares a través de:

Cambios en la rutina

Contacto físico

Claves sensoriales (voz, tacto)

No anticipa las actividades ni expresa comprensión funcional de las mismas.

Estrategias De Representación De La Información

La estudiante capta parcialmente la rutina a través de:

- Repetición constante
- Secuencia fija de actividades
- Claves sensoriales previas (contacto, movimiento, cambio de posición)

Recursos Necesarios

Recursos generales

- Apoyos físicos y posturales permanentes.
- Mobiliario adaptado (silla postural, mesa regulable).
- Rutinas estructuradas y previsibles.
- Supervisión constante por adulto
- Pausas activas y tiempos de descanso.
- Coordinación permanente con familia y equipo terapéutico.

Tecnológicos

- Videos y recursos visuales.
- Cronogramas visuales digitales.

Recursos Necesarios

- Computadora
- Andadores y ayudas para la marcha

Metodológicas

- Enfoque DUA.
- Aprendizaje funcional y significativo
- Trabajo por rutinas.
- Estimulación multisensorial
- Modelado, andamiaje y acompañamiento constante.
- Refuerzo positivo y contención emocional.

Planificación Centrada En La Persona

Objetivo: Fomentar la participación y el interés genuino de la estudiante

1. Hogar Y Familia

Área: Familiar – socioemocional – funcional

Compromiso:

- Fortalecer la participación activa de la estudiante en la dinámica familiar.
- Promover vínculos afectivos seguros.

Representación:

- Rutinas visuales del hogar.
- Fotografías de miembros de la familia.
- Canciones y cuentos familiares.

Acción y Expresión:

- Participa señalando, mirando o reaccionando ante estímulos familiares.
- Realiza pequeñas acciones funcionales con apoyo (entregar objetos, elegir).

2. Directrices

Área: Organizacional – educativa

Compromiso:

- Garantizar coherencia entre hogar, escuela y terapias.
- Mantener estructura y predictibilidad.

Representación:

- Normas simples con pictogramas.
- Señales visuales de inicio y cierre de actividades.

Acción y Expresión:

- Anticipa rutinas mediante imágenes.
- Responde a consignas simples con gestos, miradas o movimientos.

3. App – Compromiso

Área: Tecnológica – cognitiva – comunicativa

Compromiso:

- Aumentar la motivación y atención.
- Facilitar interacción con el entorno.

Representación:

- Apps con imágenes grandes, sonidos suaves y colores contrastantes.
- Videos cortos y animaciones.

Acción y Expresión:

- Interactúa tocando la pantalla con apoyo.
- Selecciona opciones mediante pulsadores o contacto asistido.

4. Salud, Rehabilitación Y Habilidad

Área: Motriz – salud integral

Compromiso:

- Favorecer el bienestar físico y prevenir la fatiga.
- Integrar objetivos terapéuticos al contexto educativo.

Representación:

- Demostraciones corporales.
- Uso de material sensorial (texturas, presión, vibración).

Acción y Expresión:

- Participa en ejercicios asistidos.
- Expresa confort o incomodidad mediante gestos o reacciones corporales.

5. Vida Social

Área: Social-emocional

Compromiso:

- Promover interacción con pares y adultos.
- Fortalecer el sentido de pertenencia.

Representación:

Juegos grupales adaptados.

Historias sociales con imágenes.

Acción y Expresión:

- Responde a saludos y estímulos sociales.
- Participa observando, sonriendo o vocalizando.

6. Movilidad Personal

Área: Motriz – autonomía funcional

Compromiso:

- Facilitar desplazamiento seguro y participación.
- Reducir barreras físicas.

Representación:

- Demostración del uso de ayudas técnicas.
- Señales visuales de desplazamiento.

Acción y Expresión:

- Realiza movimientos voluntarios asistidos.
- Mantiene posturas funcionales con apoyo.
- Participa activamente durante los traslados.

Visión de Futuro

Desde una perspectiva de calidad de vida, el equipo transdisciplinario y la familia aspiran a que la estudiante se desarrolle como una niña que participa activamente en sus rutinas diarias, se

comunica de manera funcional de acuerdo con sus posibilidades, mantiene relaciones significativas y experimenta bienestar físico y emocional. La continuidad de la equinoterapia se concibe como un apoyo relevante para su desarrollo integral.

Plan de Acción Transdisciplinario

El plan de acción se estructura a partir de las fortalezas del estudiante y se desarrolla de manera integrada entre familia, escuela y servicios terapéuticos. Cada acción contempla objetivos funcionales, ejemplos de implementación y responsables.

Área: Comunicación Funcional

Objetivo: Fortalecer la comunicación funcional de la estudiante mediante el reconocimiento y respuesta consistente a sus señales comunicativas.

Ejemplo de aplicación: Cuando la estudiante vocaliza o incrementa su tono corporal durante una actividad, el adulto interpreta esta conducta como intento comunicativo, verbaliza la intención y ajusta la actividad según la respuesta observada, promoviendo así la intencionalidad comunicativa.

Conclusiones

El Plan Centrado en la Persona presentado constituye una propuesta coherente y fundamentada para la atención educativa de una estudiante con discapacidad múltiple. Su

enfoque transdisciplinario, basado en evidencia científica y en el respeto por las fortalezas de la persona, permite orientar las acciones educativas hacia la participación, la comunicación funcional y la calidad de vida.

Actividades A Implementar

Plan Centrado en la Persona – la estudiante

Las actividades propuestas se diseñan desde un enfoque funcional, ecológico y centrado en la persona, priorizando la participación activa de la estudiante, su bienestar físico y emocional, y la generalización de aprendizajes en contextos reales (hogar-escuela-terapia).

1. Actividades De Comunicación Funcional

(Basadas en la Matriz de Comunicación)

Actividad 1: Anticipación táctil-verbal de rutinas

Fortaleza de partida:

la estudiante responde positivamente al contacto físico respetuoso y a la voz afectiva.

Descripción de la actividad:

Antes de iniciar cualquier actividad (alimentación, cambio de posición, juego, equinoterapia), el adulto realiza una clave táctil consistente (toque suave en hombro o mano) y verbaliza la acción que va a ocurrir.

Ejemplo:

“la estudiante, ahora vamos a comer”, mientras se toca suavemente su hombro.

Propósito funcional:

- Favorecer la anticipación
- Reducir ansiedad
- Fortalecer la comprensión comunicativa

Responsables: Familia, docente, fonoaudióloga

Frecuencia: Diaria, en todas las rutinas

Actividad 2: Respuesta intencional a señales corporales

Fortaleza:

la estudiante expresa agrado o desagrado mediante cambios de tono corporal y vocalizaciones.

Descripción:

El adulto observa las señales de la estudiante y responde de forma inmediata y coherente, verbalizando la intención interpretada.

Ejemplo:

Si la estudiante vocaliza y mueve brazos durante una actividad, el adulto responde:

“Veo que quieres seguir”.

Propósito:

- Reforzar la intencionalidad comunicativa
- Validar su forma de comunicarse

2. Actividades De Autonomía Asistida Y Hábitos

Actividad 3: Participación guiada en alimentación

Fortaleza:

Buena funcionalidad relativa en miembros superiores.

Descripción:

Durante la alimentación, la estudiante sostiene el utensilio con apoyo físico parcial, mientras el adulto

guía el movimiento si es necesario.

Ejemplo:

la estudiante toma la cuchara; el adulto acompaña el movimiento hacia la boca.

Propósito funcional:

- Promover participación activa

- Evitar pasividad total
- Fortalecer sentido de logro

Responsables: Familia, docente

Frecuencia: En cada comida

Actividad 4: Rutina estructurada de higiene

Fortaleza:

Beneficio de rutinas repetidas y predecibles.

Descripción:

Se mantiene un orden fijo en las actividades de higiene (lavado de manos, cambio, cepillado), usando siempre las mismas secuencias.

Ejemplo:

1. Clave táctil
2. Verbalización
3. Acción
4. Refuerzo afectivo

3. Actividades De Regulación Sensorial

Actividad 5: Pausas de regulación con presión profunda

Fortaleza:

Buena tolerancia al contacto físico respetuoso.

Descripción:

Antes o después de actividades demandantes, se realizan masajes suaves en brazos y hombros.

Ejemplo:

Masaje breve antes de pasar de juego a actividad estructurada.

Propósito:

- Favorecer regulación emocional
- Prevenir conductas de desorganización

Responsables: Familia, docente, terapeuta física

Frecuencia: Varias veces al día según necesidad

4. Actividades De Motricidad Y Postura

(Integradas con equinoterapia)

Actividad 6: Generalización postural post-equinoterapia

Fortaleza:

Respuesta positiva al movimiento rítmico del caballo.

Descripción:

Luego de la sesión de equinoterapia, se realizan actividades tranquilas en sedente con apoyo postural adecuado.

Ejemplo:

Después de montar, se propone contacto táctil, canciones suaves o comunicación uno a uno.

Propósito funcional:

- Aprovechar ventana de regulación
- Transferir beneficios de la equinoterapia a otros contextos

Responsables: Equipo de equinoterapia, familia, docente

Actividad 7: Cambios posturales asistidos

Fortaleza:

Aceptación del acompañamiento físico.

Descripción:

Durante la jornada se realizan cambios de posición (sedente, decúbito, bipedestación asistida) con apoyo físico y verbalización constante.

5. Actividades De Interacción Social

Actividad 8: Juego compartido con adulto significativo

Fortaleza:

Respuesta positiva a la presencia de adultos conocidos.

Descripción:

El adulto se posiciona frente a la estudiante, imita sus movimientos o vocalizaciones y espera respuesta.

Ejemplo:

El adulto mueve suavemente las manos cuando la estudiante vocaliza.

Propósito:

- Favorecer vínculo
- Estimular interacción social temprana

6. Actividades Con La Familia (Pcp Real)

Actividad 9: Modelado de estrategias en el hogar

Descripción:

El equipo muestra a la familia cómo aplicar las claves táctiles, la anticipación y la participación asistida en rutinas diarias.

Propósito:

- Empoderar a la familia
- Garantizar coherencia hogar-escuela-terapia

Cierre Técnico

Estas actividades:

- Parten exclusivamente de las fortalezas de la estudiante
- No buscan independencia forzada, sino participación significativa
- Son coherentes con un Plan Centrado en la Persona auténtico
- Pueden ajustarse progresivamente según respuesta funcional

Plan De Metas

Plan Centrado en la Persona – Estudiante: la estudiante

El presente plan de metas define los resultados esperados del proceso educativo y terapéutico, priorizando la participación funcional, el bienestar integral y la calidad de vida de la estudiante, en coherencia con el enfoque centrado en la persona.

Meta General

Favorecer la participación activa y significativa de la estudiante en su vida diaria, fortaleciendo su

comunicación funcional, su regulación emocional y su autonomía asistida, mediante apoyos coherentes, accesibles y coordinados entre familia, escuela y servicios terapéuticos.

Metas Específicas

1. Comunicación funcional

Fortalecer la comunicación de la estudiante, reconociendo y respondiendo de manera consistente a

sus señales corporales, gestuales y vocales, para favorecer la intencionalidad comunicativa y la interacción con su entorno.

2. Participación en rutinas diarias

Incrementar la participación de la estudiante en actividades cotidianas (alimentación, higiene, juego y desplazamiento), mediante apoyos físicos y comunicativos que respeten su ritmo y posibilidades.

3. Regulación emocional y sensorial

Promover estados de mayor regulación emocional y corporal a través de rutinas predecibles, estrategias sensoriales y experiencias significativas como la equinoterapia, favoreciendo su disposición para la interacción y el aprendizaje.

4. Bienestar postural y motriz

Favorecer el bienestar postural y la movilidad asistida de la estudiante, asegurando condiciones de

seguridad, confort y prevención de fatiga durante las actividades educativas y terapéuticas.

5. Trabajo colaborativo y sostenibilidad

Consolidar un trabajo coordinado entre familia y equipo transdisciplinario, garantizando la coherencia de las estrategias y la continuidad del Plan Centrado en la Persona en los distintos contextos de vida de la estudiante.

Estas metas no buscan la normalización ni la independencia forzada, sino la participación con sentido, el respeto por la singularidad del estudiante y la construcción de apoyos que le permitan vivir experiencias significativas y dignas.

Anexos

Recursos Y Apoyos Didácticos Alineados Al Diseño Universal

Para El Aprendizaje (Dua)

Plan Centrado en la Persona – Estudiante: la estudiante

1. Fundamentación del uso del DUA en el Plan Centrado en la Persona

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) constituye un marco pedagógico que orienta la planificación de entornos educativos accesibles, flexibles y equitativos, reconociendo la diversidad de formas en que las personas se involucran, acceden a la información y expresan lo aprendido (CAST, 2018).

En el caso de estudiantes con discapacidad múltiple, como la estudiante, el DUA permite operacionalizar el enfoque centrado en la persona, asegurando que las actividades, recursos y apoyos se adapten a sus fortalezas funcionales, canales de acceso predominantes y necesidades de regulación, favoreciendo así su participación significativa en contextos reales.

Este anexo presenta los recursos y apoyos seleccionados para la estudiante, organizados según los

tres principios del DUA y articulados con el Plan Centrado en la Persona y el trabajo

transdisciplinario del equipo.

2. Múltiples formas de COMPROMISO

(Motivación – regulación emocional – vínculo)

Recursos y apoyos implementados

- Rutinas estructuradas y predecibles
- Claves táctiles previas a cada actividad
- Voz afectiva y acompañamiento emocional constante
- Pausas sensoriales con presión profunda
- Equinoterapia como experiencia significativa y motivadora

Aplicación específica en la estudiante presenta una mejor disposición y regulación emocional cuando las actividades se

desarrollan dentro de rutinas claras, anticipadas y acompañadas por un adulto significativo. El uso de claves táctiles y verbales antes de cada acción favorece la disminución de la ansiedad y aumenta su nivel de compromiso con la actividad.

La equinoterapia se integra como un recurso clave para el compromiso, ya que el movimiento rítmico del caballo promueve la regulación postural y emocional, generando una ventana de mayor disponibilidad para la interacción y la comunicación posterior.

Ejemplo funcional

Antes de iniciar una actividad de alimentación, el adulto toca suavemente el hombro de la estudiante y verbaliza la acción (“vamos a comer”), permitiéndole anticipar la rutina y participar con mayor tranquilidad.

Sustento teórico:

El DUA destaca la importancia de promover la motivación y la autorregulación como condiciones necesarias para el aprendizaje significativo (CAST, 2018).

3. Múltiples formas de REPRESENTACIÓN

(Cómo la estudiante accede a la información)

Recursos y apoyos implementados

- Claves táctiles consistentes
- Uso de objetos reales como anticipadores (objeto-actividad)

- Lenguaje oral simple, repetitivo y contextualizado
- Contacto físico respetuoso como canal principal de acceso
- Experiencias sensoriales directas

Aplicación específica en la estudiante

Dado que la estudiante se beneficia principalmente del canal táctil y del acompañamiento físico, la

información se presenta a través de experiencias concretas y sensoriales, más que de explicaciones verbales abstractas. Los objetos reales permiten asociar acciones con significados funcionales, facilitando la comprensión de las rutinas diarias.

Ejemplo funcional

Mostrar la cuchara y colocarla suavemente en la mano de la estudiante antes de la comida permite representar la actividad de forma concreta y comprensible para ella.

Sustento teórico:

El principio de representación del DUA enfatiza la necesidad de ofrecer múltiples formas de acceso a la información, especialmente para estudiantes con barreras sensoriales o cognitivas

(Cast, 2018).

4. Múltiples formas de ACCIÓN Y EXPRESIÓN

(Cómo la estudiante participa y se expresa)

Recursos y apoyos implementados

- Participación asistida (mano sobre mano)
- Elección entre dos objetos
- Reconocimiento de movimientos, vocalizaciones y cambios posturales como

comunicación

- Respuesta inmediata y coherente del adulto a las señales comunicativas

Aplicación específica en la estudiante

La expresión de la estudiante no se limita al lenguaje oral. Sus movimientos, vocalizaciones y cambios en el tono corporal constituyen formas válidas de comunicación funcional. El equipo reconoce y responde a estas señales, promoviendo la intencionalidad comunicativa y la

participación activa en las rutinas.

Ejemplo funcional

Cuando la estudiante vocaliza o mueve los brazos durante una actividad, el adulto interpreta esta conducta como una solicitud de continuidad y responde verbalizando la intención ("quieres seguir"), reforzando su expresión.

Sustento teórico:

El DUA promueve la diversificación de las formas de acción y expresión, reconociendo que los estudiantes difieren en la manera en que demuestran participación y aprendizaje (CAST, 2018). Este enfoque es coherente con la Matriz de Comunicación, que valida todas las conductas como potenciales actos comunicativos (Rowland, 2004).

5. Articulación del DUA con el Plan Centrado en la Persona

Los recursos descritos no se implementan de manera aislada, sino que forman parte de una planificación coherente centrada en la estudiante, sus fortalezas y su calidad de vida. El DUA actúa

como un marco facilitador que permite materializar los principios del Plan Centrado en la Persona en acciones concretas, accesibles y sostenibles en los distintos contextos de participación (hogar, escuela y terapia).

6. Conclusión del Anexo

La incorporación de recursos alineados al Diseño Universal para el Aprendizaje en el Plan Centrado en la Persona de la estudiante garantiza una respuesta educativa inclusiva, flexible y respetuosa de su singularidad. Estos apoyos permiten reducir barreras, potenciar fortalezas y favorecer la participación funcional de la estudiante, fortaleciendo el trabajo transdisciplinario y el rol activo de la familia.

Anexo

Glosario De Términos Clave

Plan Centrado en la Persona (PCP):

Enfoque de planificación que pone a la persona en el centro de todas las decisiones educativas y de apoyo. Se basa en sus fortalezas, necesidades, preferencias y calidad de vida, e involucra activamente a la familia y al equipo profesional.

Equipo transdisciplinario:

Modelo de trabajo en el que distintos profesionales y la familia comparten objetivos, estrategias y responsabilidades, integrando sus saberes en un solo plan coherente, en lugar de trabajar de manera separada.

Calidad de vida:

Concepto que se refiere al bienestar general de la persona, incluyendo su salud, relaciones, participación, seguridad emocional y satisfacción con la vida, más allá de su nivel de independencia.

Participación funcional:

Forma en que una persona se involucra activamente en las actividades de la vida diaria, con o sin apoyo, de acuerdo con sus posibilidades reales.

Autonomía asistida:

Participación de la persona en una actividad con apoyo físico o verbal de un adulto, permitiéndole ser parte del proceso sin exigir independencia total.

Discapacidad múltiple:

Condición en la que una persona presenta dos o más discapacidades que interactúan entre sí, generando necesidades educativas y de apoyo complejas.

Parálisis Cerebral Infantil (PCI):

Condición neurológica permanente causada por una lesión en el cerebro en desarrollo, que

afecta el movimiento, la postura y el control muscular.

Diparesia espástica:

Tipo de parálisis cerebral en la que existe mayor compromiso motor en los miembros inferiores, acompañado de aumento del tono muscular.

Evaluación funcional:

Proceso de evaluación que se centra en observar cómo la persona se desempeña en situaciones reales de la vida cotidiana, más que en pruebas estandarizadas.

Comunicación funcional:

Cualquier forma de expresar necesidades, emociones o intenciones que resulta significativa y comprensible para el entorno, incluyendo gestos, movimientos, vocalizaciones o miradas.

Matriz de Comunicación:

Herramienta desarrollada por Charity Rowland que permite identificar y comprender las formas de comunicación de personas con discapacidades complejas, reconociendo que toda conducta puede tener intención comunicativa.

Conducta como comunicación:

Enfoque que interpreta los comportamientos de la persona como una forma de expresar necesidades, emociones o preferencias, especialmente cuando no utiliza lenguaje oral.

Claves táctiles:

Toques suaves y consistentes utilizados para anticipar actividades, comunicar cambios o brindar seguridad a la persona.

Anticipación:

Estrategia que permite a la persona saber qué va a ocurrir, reduciendo la ansiedad y facilitando la participación.

Regulación emocional:

Capacidad de mantener un estado de calma y organización corporal que permita participar

en las actividades.

Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA):

Marco pedagógico que propone ofrecer múltiples formas de motivación, acceso a la información y expresión, para atender la diversidad de los estudiantes.

Rueda DUA:

Representación gráfica de los tres principios del DUA: compromiso, representación y acción/expresión.

Equinoterapia:

Intervención terapéutica que utiliza el movimiento del caballo con fines de rehabilitación física, emocional y sensorial.

Generalización:

Capacidad de aplicar lo aprendido en un contexto (por ejemplo, terapia) a otros contextos como el hogar o la escuela.

Referencias

- CAST. (2018). Universal design for learning guidelines version 2.2.

<http://udlguidelines.cast.org>

- McCausland, D., McCallion, P., Brennan, D., & McCarron, M. (2021). The potential for person-centred planning to support participation and self-determination in people with intellectual disability. *Journal of Intellectual Disability Research*, 65(1), 5–20.

<https://doi.org/10.1111/jir.12776>

- Menor-Rodríguez, M. J., Gómez-Soria, I., & Torres-Pardo, B. (2021). Role and effects of hippotherapy in children with cerebral palsy: A systematic review of the literature. *Children*, 8(11), 1–17. <https://doi.org/10.3390/children8111036>

- Organización Mundial de la Salud. (2001). Clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud (CIF). OMS.

- Peia, F., Filippeschi, C., Simoncini, M., & Petrucci, L. (2023). Effects of hippotherapy

on postural control and balance in children with cerebral palsy: A systematic review.

International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(3), 1–15.

<https://doi.org/10.3390/ijerph20032415>

- Plotas, P., Pylawka, A., & Grzywacz, K. (2024). Effects of hippotherapy on motor function and participation in children with cerebral palsy: A meta-analysis.

Developmental Neurorehabilitation, 27(2), 95–106.

<https://doi.org/10.1080/17518423.2023.2289112>

- Ratti, V., Hassiotis, A., Crabtree, J., Deb, S., Gallagher, P., & Unwin, G. (2016). The effectiveness of person-centred planning for people with intellectual disabilities: A systematic review. Journal of Intellectual Disability Research, 60(7–8), 687–703.

<https://doi.org/10.1111/jir.12268>

- Rowland, C. (2004). Communication Matrix. Oregon Health & Science University.

<https://www.communicationmatrix.org>

- United Nations. (2006). Convention on the rights of persons with disabilities.

<https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>